ASST Navigli Ovest
Ospedale Maggiore della Darsena
Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica
S.C. Malattie Infettive - Ambulatorio HIV/IST
Direttore: Dott. Pietro Sangalli

Via Lodovico il Moro 141
20143 Milano
Tel. 02 6371 4400
Fax 02 6371 4499
amb.hiv@asst-navigliovest.example.it

AMBULATORIO HIV - NOTA DI VISITA DI FOLLOW-UP

Visita infettivologica di controllo (cod. 89.01) con consulenza farmacologica

DATI DEL PAZIENTE

Cognome:	**NDIAYE**
Nome:	**Moussa**
Nato a:	**Thiès (Senegal)**
Il:	**15/01/1987**
Cittadinanza:	**senegalese**
Domicilio:	**Via Giambellino 112, 20146 Milano**
Cellulare:	**+39 351 640 2297**
Permesso sogg.:	**n. I06642187, scad. 30/09/2026**

Data visita:	18/06/2025 ore 9:40
Cod. paziente:	HIV-MI-2016-0388
Prenotazione:	MI-CUP-25-4471902
NRE:	030A50488172036
Esenzione:	020
MMG:	Dott. Enrico Villa

C.F. N D Y M S S 8 7 A 1 5 Z 3 4 3 R

ANAMNESI INFETTIVOLOGICA

Il sig. Ndiaye, di 38 anni, magazziniere presso Logistica Lambro S.p.A., in Italia dal 2011, è seguito presso il ns. ambulatorio dal marzo 2016 per infezione da HIV-1, diagnosticata in occasione di uno screening per donazione di sangue (stadio CDC A2, nadir dei CD4 288 cellule/µL). Coinfezione da HBV (HBsAg positivo, anti-HBe positivo), con HBV-DNA stabilmente non rilevabile in terapia. Pregressa sifilide latente tardiva trattata con penicillina benzatina 2,4 MUI per 3 settimane nel 2019. Test di Mantoux e Quantiferon negativi (ultimo controllo 2024). Mai infezioni opportunistiche; in particolare non lesioni riferibili a sarcoma di Kaposi. Riferita iperbilirubinemia indiretta lieve già nota, attribuita a sindrome di Gilbert.

Convive con la compagna, sig.ra Stella Ferraresi, informata della diagnosi (notifica al partner eseguita nel 2016). La sig.ra Ferraresi esegue screening HIV semestrale presso il ns. Centro: ultimo test negativo il 04.04.25. Si ribadisce al paziente il principio U=U (non rilevabile = non trasmissibile). Il colloquio si è svolto in parte in lingua wolof con la mediatrice culturale, sig.ra Awa Diop.

TERAPIA ANTIRETROVIRALE E CONCOMITANTE

Farmaco	Posologia	In corso dal	Note
Bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide 50/200/25 mg	1 cp/die ore 20	02/05/2019	attiva anche su HBV; switch da regime con efavirenz per insonnia
Atorvastatina 10 mg	1 cp la sera	11-2023	dislipidemia
Colecalciferolo 25.000 UI	1 flac. ogni 15 gg	01/2024	ipovitaminosi D

Il paziente, di religione musulmana praticante, chiede indicazioni sull'assunzione della terapia durante il digiuno del Ramadan: si concorda l'assunzione della compressa dopo il pasto serale, mantenendo un orario costante, senza necessità di modificare il regime. Aderenza riferita ottimale (nessuna dose saltata nell'ultimo mese), confermata dal ritiro regolare dei farmaci in Farmacia Ospedaliera.

ESAMI DI LABORATORIO RECENTI

Esami eseguiti presso il Laboratorio Analisi del presidio. Valori di riferimento in nota (2).

Data prelievo	CD4 (cell/µL)	CD4 %	CD4/CD8	HIV-RNA (cp/mL)	HBV-DNA	Creatinina	Bilirubina tot.
12/12/2024	612	29%	0,74	< 20	< 10 UI/mL	1,02 mg/dL	1,9 mg/dL
3 giugno 2025	655	31%	0,81	target non rilevato	< 10 UI/mL	1,05 mg/dL	2,1 mg/dL

Altri esami del 03/06/2025: colesterolo LDL 96 mg/dL, ALT 28 U/L, eGFR 93 mL/min, esame urine nella norma. Sierologia TPHA positiva (cicatrice sierologica) con RPR non reattivo; anticorpi anti-HCV assenti.

ESAME OBIETTIVO

Buone condizioni generali. Peso 79 kg (stabile), BMI 24,6, PA 128/80 mmHg, FC 70 bpm. Cute e mucose: lieve subittero sclerale, non lesioni cutanee o del cavo orale, non candidosi. Non linfoadenomegalie superficiali. Torace: MV normotrasmesso. Addome: fegato e milza nei limiti, segno di Murphy negativo. Non deficit neurologici focali.

CONSULENZA FARMACOLOGICA

Valutate le interazioni con la farmacista, Dott.ssa Chiara Colombo: nessuna interazione clinicamente rilevante tra il regime antiretrovirale e la terapia in corso. Si raccomanda di **non** assumere integratori o antiacidi contenenti magnesio, alluminio, calcio o ferro nelle 2 ore precedenti la

compressa, e di segnalare l'eventuale uso di prodotti erboristici acquistati all'estero (il paziente si recherà nel paese di origine ad agosto).

CONCLUSIONI

Infezione da HIV-1 in soppressione virologica stabile con buon recupero immunologico; epatite B cronica HBeAg-negativa in soppressione. Dislipidemia a target. Iperbilirubinemia indiretta compatibile con sindrome di Gilbert, senza indicazione a modificare la terapia.

Programma

1. Proseguire bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide invariato; consegnate 3 confezioni.
2. Vaccinazioni: vaccino anti-HPV 9-valente (1ª dose oggi, lotto registrato in cartella) e richiamo antipneumococcico; profilassi antimalarica per il viaggio con atovaquone/proguanil, previa valutazione delle interazioni.
3. Screening IST trimestrale offerto anche alla partner.
4. Ecografia addominale e alfa-fetoproteina ogni 6 mesi (sorveglianza HBV).
5. Prossimo controllo con esami: 17 dicembre 2025, ore 9:00 (prenotazione a cura dell'ambulatorio).

Il Dirigente Medico
Dott.ssa Laura Dell'Acqua
Visto il Direttore della S.C., Dott. Pietro Sangalli

Milano, 18/06/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

S.C. MALATTIE INFETTIVE
Dott.ssa L. Dell'Acqua
Iscr. OMCeO Milano n. 38812

(1) Ai sensi della L. 135/1990 il referto è consegnato esclusivamente all'interessato, sig. M. Ndiaye, o a persona da lui delegata per iscritto; il paziente ha chiesto l'oscuramento dei dati HIV nel Fascicolo Sanitario Elettronico.
(2) Valori di riferimento: CD4 500-1500 cell/µL; rapporto CD4/CD8 > 1; creatinina 0,70-1,20 mg/dL; bilirubina totale 0,3-1,2 mg/dL.
(3) Somministrazione del vaccino registrata dall'infermiere Davide Brambilla nell'anagrafe vaccinale regionale.

Comunicazione al Medico di Medicina Generale

Egr. Dott. Enrico Villa
Medico di Medicina Generale
Via Savona 58
20144 Milano
Trasmissione riservata con il consenso dell'interessato

Gentile Collega,
Le trasmettiamo, con il consenso scritto dell'interessato acquisito in data 18/06/2025, la sintesi della visita di follow-up del comune assistito sig. Moussa N., nato il 15/01/1987.
Il paziente è in terapia antiretrovirale efficace con viremia non rilevabile e CD4 stabilmente superiori a 600 cellule/µL. Le segnaliamo in particolare:
- la necessità di verificare con il ns. ambulatorio ogni nuova prescrizione, inclusi antibiotici e antiacidi, per il rischio di interazioni con bictegravir;
- l'indicazione alla profilassi antimalarica in vista del viaggio estivo in Africa occidentale, già impostata da noi;
- il programma di sorveglianza ecografica per la coinfezione HBV, che il paziente eseguirà presso la nostra Azienda.
Per qualsiasi comunicazione può contattare direttamente la scrivente al numero 02 6371 4412 (martedì e giovedì 14-16) o all'indirizzo l.dellacqua@asst-navigliovest.example.it.
Cordiali saluti.

Dirigente Medico S.C. Malattie Infettive
Dott.ssa Laura Dell'Acqua

Milano, 18/06/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Consensi raccolti

- ☒ Comunicazione dei dati al MMG
- ☒ Contatto telefonico per richiami
- ☐ Inserimento dati HIV nel FSE
- ☐ Partecipazione a coorte di studio

Il paziente indica come persona da contattare in caso di necessità la compagna, sig.ra S. Ferraresi, tel. +39 347 905 1163; non autorizza la comunicazione della diagnosi ad altri familiari né al datore di lavoro.